



Guía

***Salud mental y calidad de vida
de pacientes en cuidados
paliativos***

Lic. Edwin Ticlla

Índice

• Introducción	04
• Qué son los cuidados paliativos	05
• Comunicación empática y compasiva	06
• El paciente con hemodiálisis: una mirada integral	07
• El apoyo psicológico: por qué es crucial	08
• Estrategias psicológicas es muy importante	12
• El papel del cuidador y su bienestar emocional	14
• La tristeza y cómo acompañar	16
• Acompañar también es sanar	17



Adquirir este producto es una excelente decisión, ya que te será de gran utilidad. Tarde o temprano, todos enfrentamos la tarea de cuidar a un ser querido, y no es necesario estar ya en esa situación para prepararse. Esta guía es una herramienta valiosa que te permitirá comprender la importancia del cuidado en los procesos de acompañamiento. Lo esencial es tomar conciencia de que el cuidador también es humano, y necesita ser comprendido para poder cuidar con amor.

Lic. Edwin Ticlla Colunche
Psicólogo



Introducción

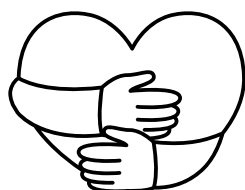
Cuidar a una persona con enfermedad renal crónica en etapa avanzada, sometida a hemodiálisis y en cuidados paliativos, etc., no es solo una tarea exclusivamente médica, implica además una **experiencia profundamente relacionada a la condición humana**. En esta guía, quiero ofrecerte una mirada cercana, compasiva y práctica sobre cómo el acompañamiento psicológico puede transformar la experiencia de enfermedad para el paciente y para ti como cuidador.

No es solo asistir en lo físico, **sino estar presente en cuerpo, mente y corazón**. Implica acompañar en la incertidumbre, sostener en el dolor, y dar sentido a los pequeños gestos cotidianos.

Porque muchas veces los familiares asumen el rol de cuidador sin preparación previa. Se enfrentan a situaciones de salud complejas, emociones intensas y decisiones difíciles, mientras intentan mantener su vida personal. Esta guía quiere ser una brújula clara para quienes están en ese camino: **no estás solo/a, hay formas de cuidar con amor sin olvidar tu propio bienestar**.

Ser cuidador es mucho más que dar medicinas o llevar al paciente a sus citas. Es escuchar cuando el otro ya no tiene fuerzas, es traducir silencios, es abrazar cuando las palabras no alcanzan. Es acompañar con respeto el proceso único de cada persona, reconociendo que el cuidado no es solo físico, sino también emocional y espiritual.

Al cuidar con el corazón, no solo ayudas al otro a sentirse en paz, también puedes descubrir en ti una fuerza y una sensibilidad que transforman. Esta guía está pensada para ayudarte a vivir ese proceso con más claridad, herramientas y, sobre todo, con humanidad.



Qué son los cuidados paliativos

Cuando escuchamos **“cuidados paliativos”**, muchas personas piensan erróneamente que se trata de *“el final”* o que *“ya no hay nada por hacer”*. Pero es todo lo contrario. Los cuidados paliativos son una forma de atención centrada en la persona, no solo en la enfermedad. Buscan mejorar la calidad de vida cuando la cura ya no es posible, pero el bienestar sí lo es.

Se enfocan en aliviar el dolor físico, pero también en acompañar las emociones, respetar los deseos del paciente, cuidar la espiritualidad y sostener a la familia. No buscan prolongar ni acortar la vida, sino hacerla más digna, tranquila y con sentido.

Los cuidados paliativos pueden iniciarse mucho antes del momento final. Se recomiendan cuando la persona vive con una enfermedad grave y progresiva, como la insuficiencia renal crónica, el cáncer avanzado o enfermedades neurológicas degenerativas. También se aplican en pacientes en hemodiálisis que ya no responden bien al tratamiento o que eligen no continuar con él.

No se trata de *“rendirse”*, sino de cambiar el enfoque del cuidado: del tratamiento agresivo a **un acompañamiento amoroso, respetuoso y compasivo**.

La familia no es un espectador, sino parte activa del proceso paliativo. Su presencia, sus palabras, su contención emocional son fundamentales para el bienestar del paciente.

Como familiar, acompañar desde este enfoque implica:

- Escuchar más allá de lo que se dice.
- Ayudar al paciente a tomar decisiones informadas y respetadas.
- Respetar su forma de afrontar el proceso (ya sea con valentía, con silencio, con fe o con miedo).
- Cuidar también de ti mismo/a, porque tu salud emocional influye directamente en la calidad del cuidado que ofreces.

Comunicación empática y compasiva

Cuando una persona está enferma o sufre, también sus familiares sufren. Esta situación genera una respuesta emocional, es decir, sentimientos como tristeza, preocupación o impotencia. Estas emociones pueden ayudar a la persona y a su familia a enfrentar mejor la enfermedad, siempre que se manejen con apoyo y cariño.

Dos actitudes muy importantes para manejar este sufrimiento son la empatía y la compasión:

- La **empatía** es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, entender cómo se siente y qué está viviendo.
- La **compasión** es esa ganas de ayudar al otro, de querer aliviar su dolor desde el corazón.

Entonces, cuando un médico, enfermero o familiar tiene una actitud empática, puede entender mejor el sufrimiento del paciente. Eso despierta la compasión, y esa compasión motiva a actuar para mejorar su situación, especialmente al momento de comunicarse con él.

Para lograr una comunicación compasiva y empática deben tenerse en cuenta las siguientes reglas:

ESTAR PRESENTE	EMPATÍA	CUIDAR
✓ Prestar atención a la persona ✓ Establecer una relación ✓ Permanecer al lado durante la situación	✓ Validar emociones ✓ Permitir el desahogo emocional ✓ Reconocer los pensamientos y necesidades	✓ Ayudar en la identificación y movilización de recursos ✓ Reducir el sufrimiento



El paciente con hemodiálisis: una mirada integral

Vivir con insuficiencia renal crónica avanzada y depender de la hemodiálisis transforma profundamente la vida de una persona. Este tratamiento, que sustituye la función de los riñones para eliminar toxinas y exceso de líquidos del cuerpo, implica asistir varias veces por semana a sesiones que duran varias horas. Aunque es vital para la supervivencia, también representa un gran desafío físico y emocional.

Desde el punto de vista físico, muchos pacientes experimentan fatiga constante, calambres, hipotensión, náuseas, y restricciones dietéticas estrictas. Esto limita su energía y capacidad para realizar actividades cotidianas, lo que puede generar frustración o sentimientos de inutilidad. A menudo, pierden su independencia, lo que afecta su autoestima y su visión de sí mismos.

En el plano emocional, no es raro que surjan sentimientos de tristeza, ansiedad o incluso depresión. La rutina de diálisis puede hacer que el paciente sienta que su vida gira exclusivamente en torno a la enfermedad. También pueden experimentar miedo al futuro, incertidumbre ante el pronóstico o preocupación por el impacto de su condición en la familia.

La hemodiálisis también impacta la vida social. Las sesiones frecuentes y los efectos secundarios pueden dificultar el mantener un trabajo, participar en reuniones familiares o sostener una vida social activa. Algunos pacientes se sienten aislados, incomprendidos o como una "carga" para los demás.

Por todo esto, es necesario adoptar una mirada integral que considere no solo los aspectos médicos, sino también las emociones, relaciones y proyectos de vida del paciente. Escuchar su historia, comprender sus miedos y validar sus emociones puede marcar una gran diferencia. La calidad de vida en hemodiálisis no depende sólo de la técnica médica, sino del apoyo humano que la rodea.

El apoyo psicológico es muy importante



El acompañamiento psicológico en cuidados paliativos no es un lujo, es una necesidad. Las personas que enfrentan una enfermedad crónica avanzada, aparte de experimentar malestar físico, también una profunda carga emocional. El miedo a la dependencia, la tristeza por los cambios en el cuerpo o la vida cotidiana, y la ansiedad frente al futuro son emociones frecuentes y válidas.

La psicología paliativa tiene como objetivo ***aliviar el sufrimiento emocional y promover una actitud de aceptación y sentido frente al proceso de enfermedad.*** Esto se logra mediante el acompañamiento empático, la validación emocional, y el uso de herramientas terapéuticas adaptadas a cada persona.

Los psicólogos ayudamos a los pacientes a:

- Expresar sus miedos, frustraciones y dudas sin sentirse juzgados.
- Elaborar el duelo por la pérdida de funciones, roles o proyectos que ya no podrán realizar.
- Reforzar sus recursos personales y espirituales.
- Encontrar nuevas fuentes de sentido, incluso en medio de la enfermedad.
- Prepararse emocionalmente para el proceso del morir, si llega a ser necesario, con mayor paz y dignidad.

Ejemplo: Una paciente que siente que ha perdido su valor al dejar de trabajar puede, a través del acompañamiento terapéutico, redescubrir su importancia como madre, amiga o fuente de sabiduría en su familia. Este cambio de perspectiva reduce el sufrimiento y mejora su bienestar emocional.



El acompañamiento psicológico también fortalece la comunicación entre el paciente, su familia y el equipo de salud, ayudando a expresar deseos, límites y prioridades de forma clara y respetuosa. Esto permite que los cuidados sean realmente personalizados y centrados en la persona.

Mediante el apoyo psicológico, se busca transformar el dolor en algo compartido, el miedo en coraje y el proceso de enfermedad en una etapa significativa de la vida. No cura el cuerpo, pero alivia el alma, y eso también es sanar. No es un proceso rápido, por ello requiere el compromiso de la familia en el proceso de adaptación.



El rol del cuidador familiar



Ser cuidador no es solo “hacer cosas” por el otro, sino estar disponible con amor y respeto. Acompañar no es decidir por el paciente, sino caminar a su lado, respetando sus tiempos, sus decisiones y su forma de vivir el proceso.

Muchas veces, por cariño, queremos proteger tanto que terminamos controlando. Pero cuidar bien es también dar espacio para que el otro conserve su autonomía, dentro de lo posible.

Escuchar, observar, contener. Tu rol como cuidador implica:

- Escuchar activamente: prestar atención a lo que dice... y a lo que no dice.

- Observar cambios de humor o comportamiento: a veces el cuerpo habla lo que las palabras no pueden.
- Contener emocionalmente: no necesitas tener todas las respuestas, solo estar presente con empatía ya es un enorme alivio para el paciente.

Una mirada cálida, una mano que acompaña, una pausa compartida pueden ser más terapéuticas que cualquier pastilla.

Es muy común que el cuidador familiar se entregue por completo y se descuide a sí mismo. Pero no se trata de desaparecer como persona para cuidar a otro. Tu salud mental, física y emocional también importa.

Algunos aspectos para cuidar sin perderte:

- **No te exijas ser “perfecto/a”.** Está bien sentirte cansado, triste o abrumado.
- **Reconoce tus propios límites.** Pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría.
- **Ten tus propios espacios.** Aún en el cuidado, necesitas momentos de descanso, risa o silencio para recargar energías.



Recuerda: No puedes dar lo que no tienes. Cuidarte a ti mismo es también una forma de cuidar mejor al otro.



Estrategias psicológicas que marcan la diferencia

En el acompañamiento de pacientes con hemodiálisis en cuidados paliativos, existen herramientas simples pero poderosas que pueden marcar una gran diferencia emocional. A continuación, te compartimos algunas estrategias psicológicas clave que también tú, como cuidador, puedes aplicar o reforzar:

- **Escucha activa** Significa estar presente con atención plena, sin interrumpir ni juzgar. A veces, el simple hecho de poder hablar y sentirse escuchado ya alivia. Mirar a los ojos, asentir, hacer preguntas suaves como "¿Cómo te has sentido hoy?" puede abrir puertas al corazón.
- **Validación emocional** En lugar de minimizar o corregir lo que el paciente siente ("no pienses eso"), es más sanador decir: "entiendo que te sientas así" o "tienes derecho a sentirte frustrado". Validar no significa estar de acuerdo, sino reconocer que su sentir es legítimo.
- **Técnicas de respiración y relajación** Respirar profundo, con calma, por unos minutos, puede disminuir la ansiedad. Puedes ayudar al paciente guiando ejercicios sencillos de respiración (*inhalar 4 segundos, retener 4, exhalar 4, retener 4*) o simplemente acompañándolo a relajarse con música suave.



Ejercicios de gratitud y recuerdos significativos. Hablar sobre recuerdos felices, logros, personas importantes o momentos de orgullo puede generar sensaciones de valor y cierre emocional. Invita al paciente a compartir sus historias: "¿Qué momento de tu vida te hizo sentir realmente feliz o valioso?"

Exploración de sentido y legado. Acompañar al paciente a reflexionar sobre el legado que quiere dejar (valores, enseñanzas, mensajes para sus seres queridos) puede brindarle una sensación de trascendencia. Esto da paz y reafirma su dignidad.

Diálogos abiertos sobre el final de la vida. Aunque es difícil, hablar sobre el miedo a la muerte, los deseos para ese momento o cómo quiere ser recordado puede disminuir la ansiedad y fortalecer los lazos familiares. No se trata de hablar solo de morir, sino de qué importa verdaderamente.

Estas estrategias no requieren conocimientos técnicos avanzados, sino presencia amorosa y apertura. Como cuidador, tú también puedes ser ese puente hacia el alivio emocional y el acompañamiento con sentido.





El papel del cuidador y su bienestar emocional

Cuidar a una persona en cuidados paliativos es un acto de amor inmenso, pero también puede ser una fuente constante de desgaste físico y emocional. Es común que los cuidadores prioricen tanto el bienestar del paciente que se olviden de cuidar de sí mismos. Sin embargo, un cuidador agotado no puede ofrecer el acompañamiento pleno que el paciente necesita.

La sobrecarga emocional puede manifestarse como ansiedad, tristeza, irritabilidad, insomnio o incluso problemas de salud. También pueden aparecer sentimientos de culpa por necesitar un descanso, o frustración al no saber cómo aliviar el sufrimiento del ser querido.

Cuidar a una persona en cuidados paliativos es un acto de amor inmenso, pero también puede ser una fuente constante de desgaste físico y emocional. Es común que los cuidadores prioricen tanto el bienestar del paciente que se olviden de cuidar de sí mismos. Sin embargo, un cuidador agotado no puede ofrecer el acompañamiento pleno que el paciente necesita.

La sobrecarga emocional puede manifestarse como ansiedad, tristeza, irritabilidad, insomnio o incluso problemas de salud. También pueden aparecer sentimientos de culpa por necesitar un descanso, o frustración al no saber cómo aliviar el sufrimiento del ser querido.

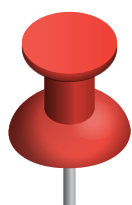
Reconocer estas emociones no es signo de debilidad, sino de humanidad. Pedir ayuda, hablar sobre lo que se siente y buscar apoyo son formas de autocuidado que también benefician al paciente.



El papel del cuidador y su bienestar emocional

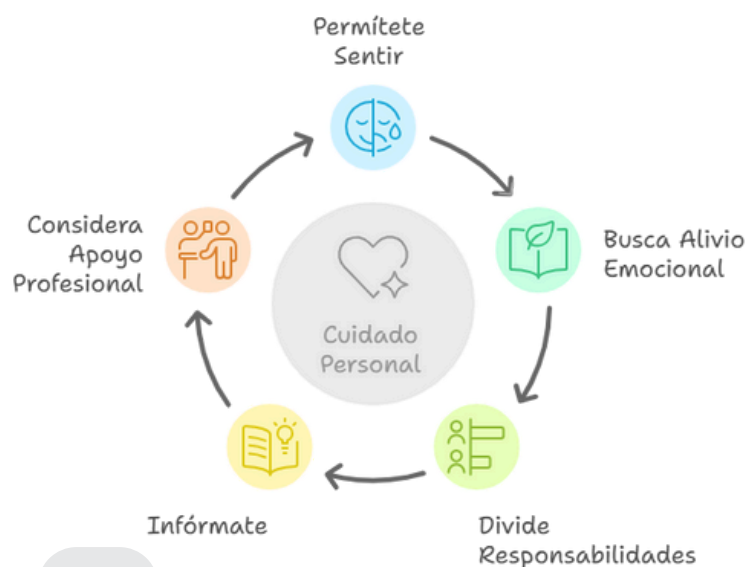
Algunas recomendaciones para cuidar de ti:

- Permítete sentir. Llorar, enojarte o cansarte es natural. No te juzgues por ello.
- Busca espacios de alivio emocional. Conversar con alguien de confianza, escribir un diario, caminar al aire libre, respirar profundo.
- Divide responsabilidades. Si hay otros familiares o personas de apoyo, distribuyan tareas. No tienes que hacerlo todo tú solo/a.
- Infórmate y capacítate. Entender la enfermedad y el proceso ayuda a disminuir la angustia. Esta guía es un buen comienzo.
- Considera apoyo profesional. Un psicólogo puede ayudarte a procesar emociones, prevenir el agotamiento y acompañarte a encontrar equilibrio.



Recuerda: cuidarte también es cuidar. Tu bienestar emocional es parte del cuidado integral que el paciente necesita. Estar bien no es un lujo, es una necesidad compartida.

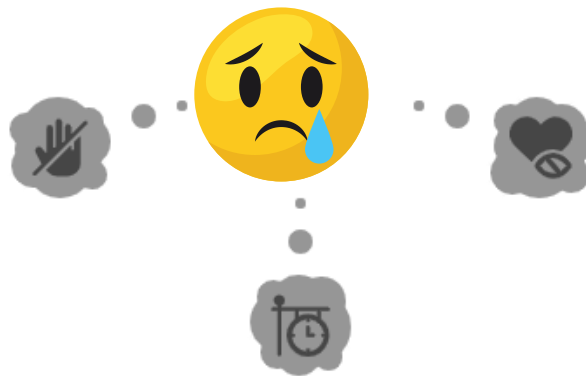
Ciclo de Cuidado Personal



La tristeza y cómo acompañar

¿Cómo acompañar la tristeza en el cuidado de enfermedades crónicas?

No apurar ni negar
Permite que la tristeza se exprese naturalmente sin presión.



Escuchar con el corazón
Proporciona apoyo emocional y comprensión.

Permitir los silencios
Respetar la necesidad de reflexión y procesamiento.



La tristeza es una de las emociones más comunes —y más incomprendidas— en el camino de una enfermedad crónica avanzada. Puede aparecer en el paciente, en los familiares y, por supuesto, en quienes cuidan.

No es un signo de debilidad, ni un problema que haya que resolver rápidamente. **Es una respuesta natural y humana ante la pérdida: de salud, de autonomía, de sueños, de certezas.** Reconocerla y acompañarla con respeto puede ser profundamente sanador.

Si no hay palabras, está bien. Acompañar también es sentarse al lado, sostener una mano, respetar el ritmo del otro médico.

Acompañar también es sanar

Acompañar a alguien en su proceso de enfermedad, especialmente en una etapa avanzada, es una de las experiencias humanas más profundas que existen. No se trata solo de estar físicamente presente, sino de ofrecer escucha, compasión, comprensión y consuelo.

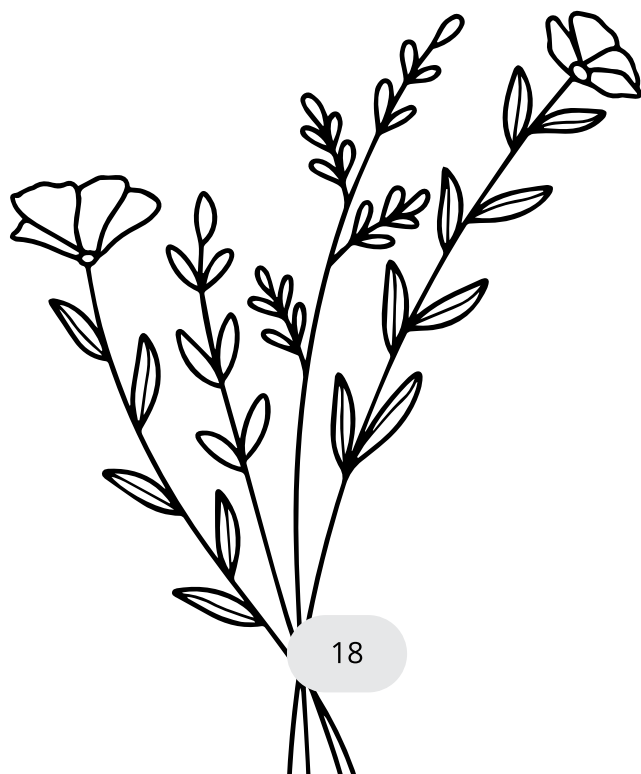
Sanar, en este contexto, no significa curar la enfermedad, sino darle sentido a la experiencia compartida. Acompañar es sanar porque permite al paciente sentirse visto, valorado y amado. Y para el cuidador, también es una oportunidad de crecer en empatía, en fortaleza interior y en el arte de amar sin condiciones.

Cada gesto de cuidado deja huella. Un abrazo, una palabra tranquila, un silencio compartido pueden ser medicina para el alma. Estar ahí, con el corazón abierto, es uno de los regalos más grandes que podemos ofrecer.

Empieza por escuchar sin juzgar. Comparte esta guía, podrías ayudar a alguien que lo necesita.



Anexos



Anexo 1: Lista de señales de alerta emocional

Estar atentos a los cambios emocionales es tan importante como vigilar los síntomas físicos. Esta lista puede ayudarte a detectar señales tempranas de sufrimiento emocional, tanto en el paciente como en ti mismo/a.

Señales de alerta en el paciente

- Cambios bruscos en el estado de ánimo (llanto frecuente, irritabilidad, apatía).
- Expresiones de desesperanza (“ya no vale la pena”, “esto no tiene sentido”).
- Retiro o aislamiento (ya no quiere recibir visitas ni hablar con nadie).
- Pérdida del interés en actividades que antes disfrutaba.
- Insomnio o sueño excesivo sin causa médica aparente.
- Cambios en el apetito (come mucho menos o pierde el interés por comer).
- Frases con ideas de muerte (“preferiría no estar aquí”, “sería mejor morir”).
- Negación constante de su situación o enojo permanente.

 Si detectas varias de estas señales de forma persistente, es recomendable consultar a un profesional en salud mental.

Anexo 2: Agenda de cuidados semanales

Día	Medicación	Hemodiálisis / Citas médicas	Actividades del paciente	Emociones observadas	Tiempo para el cuidador
Lunes					
Martes					
Miércoles					
Jueves					
Viernes					
Sábado					
Domingo					

Instrucciones de uso

- Medicación: anota hora, dosis y nombre del medicamento.
- Hemodiálisis / Citas: incluye hora, lugar, transporte necesario.
- Actividades del paciente: puede ser ver una película, caminar, conversar o simplemente descansar.
- Emociones observadas: describe brevemente si notaste tristeza, alegría, cansancio, ansiedad, etc.
- Tiempo para el cuidador: anota qué hiciste por ti (leer, salir a caminar, hablar con un amigo, etc.). Si no hiciste nada, también es importante registrarlo para estar atento.

Anexo 3: Ejercicios de relajación y respiración guiada

Las emociones intensas como el miedo, la ansiedad o la tensión física son comunes en situaciones de enfermedad crónica. Estos ejercicios simples pueden ayudar a calmar la mente y relajar el cuerpo. Se pueden hacer en casa, en silencio, o incluso durante la hemodiálisis si el paciente lo desea.

RESPIRACIÓN EN 4 TIEMPOS

(IDEAL PARA CALMAR LA ANSIEDAD)

INSTRUCCIONES:

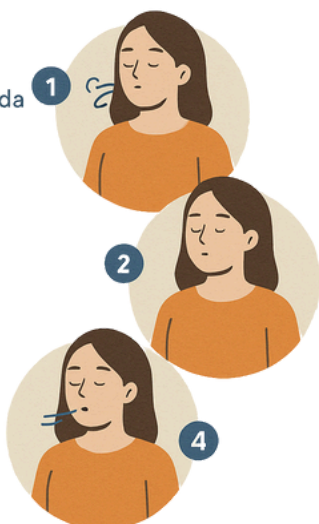
Siéntate o recuéstate en una posición cómoda

Inhala suavemente por la nariz contando hasta 4

Exhala lentamente por la boca contando hasta 4

Permanece sin aire durante 4 segundos

Repite este ciclo 4 a 6 veces



👉 Hazlo al menos 2 veces al día, o cada vez que sientas tensión. Puedes acompañarlo con música suave

Relajación muscular progresiva

(ideal antes de dormir)

Instrucciones:

- En una posición cómoda, cierra los ojos y respira hondo.
- Comienza por los pies: apriétalos fuerte por 5 segundos, luego suelta y relaja.
- Sube a las piernas, muslos, abdomen, manos, brazos, hombros y rostro.
- En cada parte, contrae los músculos por unos segundos y luego relájalos profundamente
- Al finalizar, permanece en silencio respirando lentamente unos minutos.

➔ Este ejercicio ayuda a liberar la tensión física acumulada por el estrés o el dolor.



VISUALIZACIÓN GUIADA

(ideal para momentos de mucha carga emocional)

CIERRA LOS OJOS Y PERSPIRA PROFUNDO

IMAGINA UN LUGAR QUE TE DE PAZ: UNA PLAYA, UN BOSQUE, UNA HABITACION TRANQUILA



VISUALIZA LOS COLORES, LOS SONIDOS, LA TEMPERATURA... COMO SI ESTUVIERAS ALLÍ

QUÉDATE EN ESE LUGAR MENTAL POR UNOS MINUTOS, RESPIRANDO CON CALMA

REGRESA LENTAMENTE AL PRESENTE, ABRIENDO LOS OJOS CON SUAVIDAD

Anexo 4: Frases útiles para acompañar emocionalmente

En momentos difíciles, las palabras tienen un gran poder. Una frase dicha con amor y respeto puede aliviar la angustia, dar seguridad o simplemente hacer sentir al otro que no está solo.

Para validar emociones

- “Es normal que te sientas así.”
- “Estoy aquí para ti, aunque no tengas ganas de hablar.”
- “No necesitas estar fuerte todo el tiempo.”

Para escuchar sin juzgar

- “¿Quieres contarme cómo te sentís hoy?”
- “No tengo todas las respuestas, pero quiero escucharte.”
- “Puedo quedarme en silencio contigo si lo prefieres.”

Para ofrecer apoyo sin presión

- “¿Quieres que estemos en silencio o prefieres conversar?”
- “¿Cómo puedo ayudarte hoy de la forma que vos necesites?”
- “Estoy acá para acompañarte, no para cambiar lo que sentís.”

Para reconectar con momentos de valor

- “¿Te acuerdas de aquella vez que...?” (recuerdos positivos)
- “Siempre admiré tu forma de enfrentar las cosas.”
- “A pesar de todo esto, segues siendo tu: valiente, humano/a, auténtico/a.”

Qué evitar decir (aunque sean con buenas intenciones)

 “No llores.”

 “No estés triste.”

 “No pienses en eso.”

 “Todo va a estar bien” (cuando no lo sabemos).

 En su lugar, opta por el silencio respetuoso, el contacto físico si lo permite, y una actitud de presencia sincera.

Anexo 5: Diario emocional del cuidador

Cuidar a otro implica una montaña rusa de emociones. El cansancio, la ternura, la impotencia, la culpa, la gratitud... todas pueden aparecer en un solo día. Escribir lo que sientes te ayuda a procesarlo, comprenderlo y liberar tensión emocional.

Este diario es un espacio para ti: no hay respuestas correctas ni juicios. Solo una pausa para reconectar contigo mismo/a.



Modelo de registro diario

Fecha: _____ Hora aproximada: _____

1. Cómo me siento hoy?

(Puede ser una palabra, una emoción, una imagen)

Ej: cansado, triste, agradecido, abrumado...

2. Qué fue lo más difícil del día?

(Puede ser algo físico, emocional o relacional)

Ej: ver llorar al paciente, sentirme solo/a, no dormir bien...

3. Qué me hizo bien hoy, aunque sea pequeño?

(Un momento, una persona, un pensamiento)

Ej: una charla con mi hermana, una canción, un mensaje de apoyo...

4. Qué necesito hoy que no me estoy dando?

(Puede ser descanso, contención, tiempo para mí, ida...)

Ej: necesito dormir más, necesito hablar con alguien, necesito respirar...

5. Algo que quiero agradecer o dejar por escrito?

(Un pensamiento libre, un deseo, una oración)

Ej: agradezco haber podido estar presente.

Deseo tener más paciencia.

✨ Recomendaciones de uso

Escribe cuando puedas, no te preocupes por la redacción: escribí como te salga. Guárdalo en un lugar personal. Es tu espacio íntimo.

Gracias.

Gracias por estar, por acompañar, por sostener con amor incluso en los días difíciles.

Si llegaste hasta aquí, es porque has elegido cuidar con el corazón abierto. Y eso merece ser reconocido, valorado y agradecido profundamente. **Esta guía fue pensada para ti, que entregas tiempo, energía y ternura a alguien que atraviesa un momento delicado de su vida.**

Sé que cuidar no es fácil. A veces es invisible, solitario o agotador. Por eso queremos decirte con fuerza: **tú también importas.** Tu salud emocional, tu descanso, tus lágrimas contenidas, tu necesidad de respirar y tu derecho a pedir ayuda.

No estás solo/a. Hay una red —aunque sea pequeña— que puede sostenerte si la buscas.

Tu presencia transforma. **No hace falta ser perfecto para ser un gran cuidador.** Con solo estar, escuchar, acariciar, esperar en silencio... ya estás haciendo muchísimo. Y eso queda. Queda en la memoria del paciente, en tu corazón y en la huella humana que deja todo acto de amor genuino.

Ojalá esta guía te haya servido para sentirte más acompañado/a, más informado/a y, sobre todo, más comprendido/a.

Bibliografía

- Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP). (2020). Guía de psicología en cuidados paliativos. <https://cuidadospaliativos.org/uploads/2020/12/Guia%20de%20psicologia%20en%20CP.pdf>
- Bermejo, J. C. (2019). Counselling al final de la vida y en el duelo. *Clínica Contemporánea*, 10(e2), 1–12. <https://doi.org/10.5093/cc2019a1>
- Blázquez, P. (2024, noviembre 5). Está siendo fácil porque nos queremos. Cadena SER. <https://cadenaser.com/castillalamancha/2024/11/05/pablo-que-cuida-a-su-mujer-yolanda-que-sufre-alzheimer-esta-siendo-facil-porque-nos-queremos-ser-talavera/>
- Cabrales, A. J., Torres, V. E., Pérez, J. D., & Chávez, A. R. (2017). Factores asociados a ansiedad y desesperanza en pacientes con enfermedad renal crónica. *Revista Mexicana de Investigación en Psicología*, 9(1), 46–53.
- Calvanese, N., Feldman, L., & Weisinger, J. (2004). Estilos de afrontamiento y adaptación en pacientes sometidos a hemodiálisis. *Revista de Nefrología Latinoamericana*, 11, 49–63.
- Chavez, M. (s.f.). No me arrepiento de nada. VITAS Healthcare. <https://espanol.vitas.com/family-and-caregiver-support/caregiving/first-time-caregivers/family-caregivers-share-their-personal-experiences/>
- Di Donato, M. D. L. M., Giusti, S. D., & Amigone Forte, J. (2020). Cuidados paliativos: El rol del psicólogo en el abordaje interdisciplinario. XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. <https://www.aacademica.org/000-007/653.pdf>
- Fernández-Alcántara, M., Ortega-Valdivieso, A., Pérez-Marfil, M. N., García-Caro, M. P., & Cruz-Quintana, F. (2014). Funciones y situación actual de la intervención de los psicólogos en cuidados paliativos. *Psicooncología*, 11(1), 5–20. https://doi.org/10.5209/rev_PSIC.2014.v11.n1.44925
- García-Arista, A., & Arredondo-Pantaleón, A. J. (2018). La psiconefrología: Un campo de estudio en desarrollo. *Psicología y Salud*, 28(2), 261–269.
- Juana. (s.f.). Testimonio: cuidadora de sus dos padres. El Rincón del Cuidador. <https://www.elrincondelcuidador.es/otros-cuidados/testimonio-cuidadora-de-sus-dos-padres>
- Melisa Tuya. (2024, noviembre 5). La soledad y el desgaste de los familiares cuidadores, en primera persona. El País. <https://elpais.com/mamas-papas/actualidad/2024-11-05/la-soledad-y-el-desgaste-de-los-familiares-cuidadores-en-primera-persona.html>
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). (s.f.). Cuidados paliativos. <https://www.paho.org/es/temas/cuidados-paliativos>
- Puchalski, C., et al. (2009). Improving the Quality of Spiritual Care as a Dimension of Palliative Care: The Report of the Consensus Conference. *Journal of Palliative Medicine*, 12(10), 885–904. <https://doi.org/10.1089/jpm.2009.0142>

